Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO / IDENTIFICACIÓ DEL CENTRE	
SERVICIO DE SALUD / SERVEI DE SALUT	Conselleria de Sanitat - GVA
DENOMINACIÓN DEL CENTRO / DENOMINACIÓ DEL CENTRE	HOSPITAL GENERAL DE CASTELLON
UNIDAD ASISTENCIAL RESPONSABLE / UNITAT ASSISTENCIAL RESPONSABLE	Servicio de Urgencia Hospitalaria
SERVICIO / SERVEI	URGENCIAS
NÚM.DE EPISODIO / NÚM.D'EPISODI	
FECHA DE INGRESO / DATA D'INGRÉS	06/01/2022
FECHA Y HORA DE ALTA / DATA I HORA D'ALTA	06/01/2022

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE / IDENTIFICACIÓ DEL PACIENT			
PRIMER APELLIDO / PRIMER COGNOM			
SEGUNDO APELLIDO / SEGON COGNOM			
NOMBRE / NOM			
CIP DE LA CA / CIP DE LA CA		Nº Hª CLÍNICA / Nº Hª CLÍNICA	
CIP EUROPEO / CIP EUROPEU		CÓDIGO SNS / CODI SNS	
SEXO / SEXE	Mujer	F. NACIMIENTO / D. NAIXIMENT	
DIRECCIÓN / DIRECCIÓ			

Datos generales del paciente / Dades generals del pacient

Procedencia / Procedència: PARTICULAR

Motivo de la atención / Motiu de l'atenció: Remitida por disnea (sospecha covid). Un poco de mocos y tos.
- Código alerta SEPSIS

Antecedentes / Antecedents:

RAM: niega.

Antecedentes Respiratorios:
-Ex-fumadora desde hace mas de 40 años de 4 cig/dia.
- Tras viaje prolongado en coche a Alemania, TVP + TEP bilateral en Francia en 2016, en tratamiento una temporada con Xarelto.
- TBC en la infancia (TAC del 2017 hallazgos compatibles con cambios post TBC).
-Portadora de VMNI por SAOS (BiPAP puesta en Navarra).

Antecedentes personales:
- Dislipemia.
- Ictus vertebrobasilar en sept 2021.
- Deterioro cognitivo desde ingreso por ictus vertebrobasilar en estudio por Neurología.
- Elevación hemidiafragma derecho.
- Insuficiencia tricuspídea moderada.

Tratamiento habitual:
-ADIRO 100MG
-MELITRACENO CLORHIDRATO / FLUPENTIXOL DICLORHIDRATO GRAGEAS 10 MG / 0,5 MG.
-DONEPEZILO COMPRIMIDOS 5 MG.
-BROMURO DE TIOTROPIO CAPSULAS + DISPOSITIVO 18 MCG.
-URIDINA TRIFOSFATO CAPSULAS 1,33 MG.
-PANTOPRAZOL 20 MG.
-THICK AND EASY SABOR NEUTRO.

Social: vive con el marido. Independiente para ABVD. Barthel 100. Rankin 0

Refiere 2 vacunas para SARS-2 aunque no constan en abucasis.

Marido Pierre tlf 667493227

Enfermedad o proceso actual / Malaltia o procés actual: Paciente de 83 años traida en SVB a SUH por saturación baja. La paciente refiere aumento brusco de su disnea habitual desde hace una semana. No sintomatología infecciosa salvo congestión nasal. No fiebre.
No edemas de MMII, no disminución de la diuresis. No otra sintomatología.

Exploración física / Exploració física: 06-01-2022 11:26 - Tª: 35.6 ºC (Timpánica); FC: 97 lat/min (Rítmica); Sat. O2: 70 % (Sin Oxígeno)
Auscultación cardíaca: Tonos cardiacos regulares, sin soplos audibles.
Auscultación pulmonar: murmullo vesicular conservado, disminución de mv en base pulmonar derecha. Taquipneica en reposo sin oxigenoterapia.
Abdomen blando y depresible, no doloroso a la palpación, sin signos de irritación peritoneal. Murphy negativo, Blumberg negativo. No palpo masas ni megalias. Puño-percusión renal bilateral no dolorosa. Peristaltismo conservado.
MMII: sin edemas.

Informe de Urgencias
Informe d'Urgències

Exploraciones complementarias / Exploracions complementaries:

Evolución / Evolució:

ECG ritmo sinusal, eje +60º, PR 0'12s, QRS estrecho, BRD.

GASOMETRÍA ARTERIAL (aa) pH: 7.46 pO2: 45 satO2: 74.1 CO2: 24 HCO3: 20.4 AG: 15

HEMOSTASIA

T. PROTROMBINA	11,7 seg	(9,0 - 13,0)
INDICE DE QUICK	97,0 %	(70,0 - 120,0)
INR	1,02	(0,80 - 1,20)
TP RATIO	1,02	(0,80 - 1,20)
TTPA RATIO	1,01	(0,80 - 1,25)
T.TROMBOPLASTINA PARCIAL ACTIV	31,7 seg	(25,1 - 38)
FIBRINOGENO	* 777,00 mg/dL	(200,00 - 400,00)
DIMEROS D	* 3.831,00 ng/mL	(0 - 500)

HEMOGRAMA

HEMATIES	5,09 x 10^6/µL	(4,20 - 6,10)
HEMOGLOBINA	15,2 g/dL	(12,0 - 18,0)
HEMATOCRITO	47,3 %	(37,0 - 52,0)
VOLUMEN CORPUSCULAR MEDIO	92,9 fL	(80 - 94)
HBG CORPUSCULAR MEDIA	29,8 pg	(27,0 - 31,0)
CONC. HBG CORPUSCULAR MEDIA	* 32,0 g/dL	(33,0 - 37,0)
RDW-CV	13,6 %	(11,6 - 14,5)
LEUCOCITOS	* 14,30 x 10^3/µL	(4,80 - 10,80)
NEUTROFILOS	* 8,90 x 10^3/µL	(1,90 - 8,00)
LINFOCITOS	3,40 x 10^3/µL	(0,90 - 5,20)
MONOCITOS	* 1,80 x 10^3/µL	(0,16 - 1,00)
EOSINOFILOS	0,10 x 10^3/µL	(0,00 - 0,80)
BASOFILOS	0,10 x 10^3/µL	(0,00 - 0,20)
NEUTROFILOS %	62,7 %	(40,0 - 70,0)
LINFOCITOS %	23,7 %	(19,0 - 48,0)
MONOCITOS %	* 12,3 %	(3,4 - 9,0)
EOSINOFILOS %	0,6 %	(0,0 - 7,0)
BASOFILOS %	0,7 %	(0,0 - 1,5)
PLAQUETAS	305 x 10^3/µL	(130 - 400)

1ª BIOQUÍMICA

PROCALCITONINA	0,05 ng/mL	(0.00-0.10)
TROPONINA ULTRASENSIBLE	* 76,68 ng/L	(0,02 - 14,00)
MIOGLOBINA	46 ng/mL	(12 - 70)
GLUCOSA	* 264	

mg/dL (70 - 110)
UREA * 51 mg/dL (10.0 -- 50.0)
CREATININA * 1,01 mg/dL (0,51 - 0,95)
FILTRADO GLOM.ESTIMADO CKD-EPI * 51,52 ml/min/sup (60.00-200.0)
SODIO 137 mmol/L (134-145)
POTASIO 4,37 mmol/L (3.50-5.00)
CLORO 102 mmol/L (95-105)
BILIRRUBINA TOTAL 0,62 mg/dL (0.50-1.0)
GPT * 47 UI/L (10-37)
GOT * 55 UI/L (10-38)
GGT * 219 UI/L (7.0-50)
FOSFATASA ALCALINA * 175 UI/L (40-145)
CPK * 48 UI/L (50-195.0)
LDH * 274 UI/L (0 - 248)
PROTEINA C REACTIVA * 66,44 mg/L (1.00-10.0)
FERRITINA 222 ng/mL (20 - 300)
NT- PROBNP * 11.924 pg/mL (20 - 125)

2ª BIOQUÍMICA
TROPONINA ULTRASENSIBLE * 65,34 ng/L

RX TÓRAX
Estudio portátil, poco inspirado. Elevación diafragmática derecha. Elongación de troncos supraaórticos.
No hay evidencia de consolidaciones del espacio aéreo.

TAC VASCULAR ARTERIAS PULMONARES
Defectos de repleción bilaterales compatibles con TEP agudo en arterias:
- apical y segmentaria anterior del LSD, lobar media y lobar inferior derecha
- segmentaria anterior del LSI, basal anteromedial, basal lateral y basal posterior del LII

No se observan defectos de repleción en las arterias pulmonares principales ni en el cono de la pulmonar.
Áreas parcheadas en vidrio deslustrado, predominantemente de distribución peribroncovascular, que podrían estar en relación con el TEP (trastornos de la ventilación-perfusión), sin observar consolidaciones alveolares.
Aplamiento y rectificación del tabique interventricular, así como reflujo de contraste a venca cava inferior como signos de sobrecarga de cavidades cardíacas derechas.
Atelectasia-líquido en cisura menor derecha.
No derrame pleural.
Bocio endotorácico izquierdo.
Elevación de hemidiafragma derecho.

Atrofia renal derecha.

PCR Nuevo Coronavirus 2019-nCoV
NEGATIVO

Detección antígeno SARS-CoV-2
NEGATIVO

Se administra filtamask a 6lpm manteniendo SatO2 95%
Se administra solu-moderin 125mg (en centro de salud se ha administrado urbason 60mg)+ 3 inhalaciones de atrovent + 1 inhalación de budesonida + 1 ampolla de furosemida.

GUARDIA DE NEUMOLOGÍA (Dra. Acosta/Dra. Saravia)
-Paciente 83 años con los antededentes de TEP en 2016,TBC en la infancia y portadora de VMNI por SAOS que acude por aumento de su disnea basal desde hace una semana.
A nuestra valoración la paciente se encuentra saturando 94% con FMK a 6lx´.
En aparente buen estado general,Disneica al habla.No uso demusculatura accesoria.
AP: Disminución del MVC.
EEII: No edemas no signos de TVP.
En Angio-TAC TEP Agudo.

Se decide ingreso a cargo de Neumología para iniciar tratamiento y ver evolución.

Diagnóstico principal / Diagnòstic principal: TEP AGUDO BILATERAL

Tratamiento al alta / Tractament a l'alta: -Ver Orion.
-Hacemos IC para solicitar Ecocardiografía.
-Hacemos IC. para solicitar Eco-Doppler de MMII.

Circunstancias al alta / Circumstàncies a l'alta: PASO A HOSPITALIZACIÓN - NEUMOLOGIA

Responsable: **Firma digital / Signatura digital:**

Sección / Secció: URGENCIAS

Fecha / Data:

Fecha creación / Data creació: 06/01/2022